

--

Name: كريمه حنفي بكر السيد National ID: 27510030102924	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Contrast-enhanced CT of chest and abdomen
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



كريمة
حنفي بكر السيد
١٥ اش توفيق ابو خضرة - بشتيل
مركز اوسيم - الجيزة



٢٧٥ ١٠٠٣٠١٠٢٩ ٢٤
IQ0032568

٢٠٢٠/١١ ٢٧٥١٠٠٣٠١٠٢٩ ٢٤

ربة منزل
انثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/١١/٠١



اسم المريض بالإنجليزية: Karimah Hanafi Bakr	كود المريض: 97799
تاريخ التقرير: 2026/08/03 12:04:43 PM	السن: ٥٠ سنة, ٩ شهر

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 51 years old female patient with left breast lump and nipple retraction .

Detailed Findings

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- UOQ asymmetrical density ,distortion and segmental suspicious calcifications reaching nipple ,all in area about 11x44mm and mild skin thickening
- Ultrasound revealed mass and non mass lesion seen between 1-4 o'clock zone a, b& c measuring about 11x5cm reaching nipple with skin thickening 4mm seen at UOQ& UIQ
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, II with effaced hila, largest one measures about 29x9 mm at level I and 22x9mm at level II
- No infra or supraclavicular pathological lymph nodes,

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Left breast (BIRADS 5): local advanced malignant process with ipsilateral pathological axillary (tru cut biopsy was taken at same sitting)
- Right breast (BIRADS 2): adenosis .

*Much obliged,
Dr. Marwa M.Hassan*



رسوم الاستعلام 20 جنية

تاريخ الاصدار: 2026-8-3

جهة الاصدار: فرع الجيزة

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للاحتفاع الخاضعين لقانون التأمين
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات
والارامل" وكذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 "
الاطفال دون السن المدرسي" وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعية
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعي

والبحت تبين أن

السيد (ة) كريمه حنفى بكر بطاقة رقم 27510030102924

تليفون رقم: لا يوجد

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
باعتبار من الفئات غير المنتفعة بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسؤولية على الهيئة
العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

الموظف المختص

تاريخ الطباعة: 2026-8-3

مى ابو الخير

إفادة مركز نظم المعلومات
بجتمه



مستلم 2039609

الخطاب سارى لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغيير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو
وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



كريمة

حنفي بكر السيد

١٥ ش توفيق ابو خضرة - بشتيل

مركز اوسيم - الجيزة

١٩٧٥/١



٢٧٥ ١٠ ٠٣ ٠١ ٠٢٩ ٢٤

IQ0032568



Patient Name	كريمه حنفى بكر	Case No.	360788
Sex/Age	Female 50 Y	Patient No.	25530
Registered Date	26/8/2026 03:41:02 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 01:28:04 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	17/9/2026 12:39:03 PM	Pathology No.	2468/26

Pathology Report

Clinical Data: Left breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 04/08/2026. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Multiple fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.2 cm & 0.8 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- CK (AE1/AE3), ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive lobular carcinoma.
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1).
- DCIS: Absent.
- Microcalcification: Absent.
- Angioinvasion: Absent.
- Perineural invasion: Absent.

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- CK: Positive in tumor cells.
- ER: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: No membrane reaction in tumor cells (score 0).
- Ki67%: 45%.

Conclusion:

- Left breast mass, Tru-cut biopsy:
- Invasive lobular carcinoma, Grade 2.
- IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).

9/17/26, 12:39 PM

360788|6423|



Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناتيونال - مصر - مختبر علم الأمراض



Patient Name	كريمة حنفى بكر	Case No.	360788
Sex/Age	Female 50 Y	Patient No.	25530
Registered Date	26/8/2026 03:41:02 PM	Referred By Dr.	Out Patient
Validation Date	07/9/2026 01:28:04 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	17/9/2026 12:39:03 PM	Pathology No.	2468/26

- Her2: Negative (score 0).

- Ki67%: 45%.

****Scoring system: "ER, PR"**

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

**** Scoring system: "Her2"**

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within > 10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim. MD.

اسم المريض بالإنجليزية: Kerimah Haneß Bakr	كود المريض: 97799	
تاريخ الفحص: 2026/08/03 12:04:43 PM	السن: ٥٠ سنة، ٩ شهر	

3

Women's Health Outreach Program

Bilateral Full field Digital Mammography and high-resolution ultrasound.

Clinical summary: 51 years old female patient with left breast lump and nipple retraction.

Detailed Findings

Left breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- UOQ asymmetrical density ,distortion and segmental suspicious calcifications reaching nipple ,all in area about 11x44mm and mild skin thickening
- Ultrasound revealed mass and non mass lesion seen between 1-4 o'clock zone a, b& c measuring about 11x5cm reaching nipple with skin thickening 4mm seen at UOQ& UIQ
- Multiple enlarged axillary lymph nodes at level I, II with effaced hila, largest one measures about 29x9 mm at level I and 22x9mm at level II
- No infra or supraclavicular pathological lymph nodes,

Right breast:

- Scattered fibro glandular densities (ACR density B).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- Ultrasound demonstrated prominent glandular elements of the breast tissue with mottled appearance.
- Multiple small dispersed subcentimetric thin-walled anechoic cysts.
- Normal skin/subcutaneous tissue and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Impression:

- Left breast (BIRADS 5): local advanced malignant process with ipsilateral pathological axillary (tru cut biopsy was taken at same sitting)
- Right breast (BIRADS 2): adenosis .

*Much obliged,
Dr. Maryam M. Hassan*